REIN · SURRÉNALE · RS-01

Masse kystique rénale · Bosniak 2019

Bosniak v2019
scanner et IRM · protocole masse rénale

Prérequis : scanner ou IRM avec **protocole « masse rénale »** (sans injection + phase néphrographique ± tardive). Système de prédiction de malignité, non de prise en charge. La taille et les calcifications n'entrent plus dans la classification. Définitions : paroi ou cloison **fine ≤ 2 mm**, **discrètement épaissie 3 mm**, **épaisse ≥ 4 mm** ; cloisons **peu nombreuses 1–3**, **nombreuses ≥ 4**.

CLASSIFICATION BOSNIAK V2019

CLASSE	SCANNER	IRM	MALIGNITÉ	CONDUITE
I	Bien limité, paroi fine et lisse (≤ 2 mm) rehaussée, **liquide simple** (−9 à 20 UH ; signal liquidien en IRM), ni cloison ni calcification		≈ 0 %	Aucune
II	• Kystique avec 1–3 cloisons fines rehaussées • Homogène **≥ 70 UH** sans injection • Homogène non rehaussé > 20 UH (protocole masse rénale) • Homogène −9 à 20 UH sans injection • Homogène 21–30 UH en phase portale • Homogène hypodense trop petit pour être caractérisé	• Cloisons fines peu nombreuses • Homogène **très intense en T2** (sans injection) • Homogène **très intense en T1** (≈ 2,5 × le parenchyme) sans injection	≈ 0 %	Aucune
IIF	Paroi lisse **discrètement épaissie (3 mm)** rehaussée, ou cloison(s) lisse(s) discrètement épaissie(s), ou **≥ 4 cloisons** fines lisses rehaussées. IRM : aussi kyste hétérogène hyperintense T1 en saturation de graisse		≈ 5–10 %	Contrôle à 6 et 12 mois puis annuel pendant 5 ans
III	Paroi ou cloison(s) **épaisse(s) ≥ 4 mm** ou **irrégulière(s)** (protrusion à bords obtus ≤ 3 mm) rehaussée(s)		≈ 50 %	Surveillance active ou chirurgie / ablation
IV	**Nodule rehaussé** : protrusion à bords obtus ≥ 4 mm, ou protrusion à **bords aigus** de toute taille		≈ 90 %	Chirurgie ou ablation

Rehaussement : en scanner, ≥ 20 UH entre sans et avec injection ; en IRM, rehaussement visible ou en soustraction. Une masse avec > 25 % de composante tissulaire n'est pas un kyste : c'est une masse solide.

PIÈGES

Techniques

- Pseudo-rehaussement en scanner (petits kystes, phase néphrographique, scanner double énergie utile)
- Coupes trop épaisses : paroi mal mesurée
- L'IRM peut sur-classer (cloisons plus visibles) : interpréter avec prudence

Lésionnels

- Kyste hémorragique ou infecté : ne pas classer en phase aiguë, contrôler
- Calcifications épaisses masquant un rehaussement : compléter par IRM ou CEUS
- CEUS : très sensible au rehaussement des cloisons, tendance à sur-classer

COMPTE RENDU

Taille et siège
rein, pôle, exophytique ou non

Paroi et cloisons
épaisseur en mm, nombre, régularité, rehaussement

Nodule
bords obtus ou aigus, taille de la protrusion

Classe et conduite
Bosniak v2019 et proposition de suivi

Masse kystique rénale · Bosniak 2019 (suite)

ATLAS VISUEL

Classes de Bosniak v2019 (après injection)



I	II	IIF	III	IV
paroi fine ≤ 2 mm, liquide	1–3 cloisons fines	≥ 4 cloisons ou paroi 3 mm	paroi ou cloison ≥ 4 mm, irrégulière	nodule rehaussé

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Bosniak v2019
Radiopaedia · définitions
radiopaedia.org/articles/bosniak-classification-

Bosniak : illustrations
Radiopaedia · schémas des classes
radiopaedia.org/cases/bosniak-classification-of-

Kyste Bosniak IV (cas)
Radiopaedia · nodule rehaussé
radiopaedia.org/cases/renal-cyst-bosniak-class-i

Sources : Silverman et al., Radiology 2019 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2019182646 · Bosniak v2019 pitfalls (Abdom Radiol) – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00261-020-02906-8.pdf · Bosniak 2019 – CEUS (Med Ultrason) – medultrason.ro/medultrason/index.php/medultrason/article/dow...